혈압약, 왜 사람마다 다를까요

혈압을 낮추는 약은 여러 종류입니다. 효과와 주의할 증상을 함께 살펴봅니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

혈압약 선택에 중요한 세 가지

어떤 약을 쓸지는 동반 질환과 부작용을 함께 보고 정합니다.

1

약 종류는 함께 앓는 병으로 고릅니다

혈압약 종류끼리 평균적인 혈압 감소 폭은 비슷합니다. 심부전·단백뇨·심장혈관병·빠른 맥박 등 함께 앓는 병과 주의사항에 맞춰 고릅니다.

같은 종류여도 약마다 하루 동안 효과가 이어지는 시간이 다릅니다.

함께 앓는 병 → 약 종류

2

증량보다 2제 병용

한 약의 용량을 2배로 늘리면 추가 효과는 약 20%에 그칩니다. 다른 종류를 함께 쓰면 추가 효과가 약 5배 큽니다.

대부분은 서로 다른 두 약으로 시작할 수 있습니다.

약을 더할지는 의사와 상의

3

금기 조합 두 가지

혈압을 올리는 호르몬을 막는 두 계열의 약은 함께 쓰지 않습니다. 맥박을 늦추는 약 두 종류를 함께 쓰면 맥박이 너무 느려질 수 있습니다.

임신 중에는 호르몬 억제약을 쓰지 않습니다.

처방 전 병용약 확인

실천 · 혈압 수치와 다른 질환을 함께 알려 주시면 약을 고르는 데 도움이 됩니다.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

약을 두 가지 이상 쓰는 이유

한 약을 계속 늘리는 것보다 다른 방식의 약을 더하는 편이 나을 수 있습니다.

1

두 가지 약부터

혈압 호르몬을 막는 약에 혈관을 넓히거나 소변을 늘리는 약을 더할 수 있습니다. 한 알 복합제로 먹기도 합니다.

대부분 환자에서 시작

2

세 가지 약

호르몬 억제약 + 혈관 확장약 + 이뇨제를 함께 씁니다. 한 알 복합제를 우선합니다.

용량 최적화 확인

3

네 번째 약이 필요한 경우

세 가지 약을 적절히 써도 높다면 복용·측정 문제부터 확인합니다. 콩팥 기능과 칼륨을 본 뒤 스피로노락톤 25~50 mg/일을 의사가 검토할 수 있습니다.

비교 연구 근거

4

적응이 있으면 베타차단제

심장 힘이 약한 심부전, 관상동맥질환, 심방세동의 맥박 조절, 빠른 맥박이 있으면 베타차단제를 함께 쓸 수 있습니다.

함께 앓는 병 우선

위험이 낮은 1기 고혈압이거나 고령·허약한 분은 한 가지 약으로 시작할 수 있습니다

실천 · 약을 늘리기 전 집에서 잰 혈압과 실제 복용 여부를 확인하세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

세 가지 약을 먹어도 높다면, 먼저 원인을 찾습니다

복용한 약·집에서 잰 혈압·생활습관을 함께 보면 다음 치료를 정할 수 있습니다

측정이 맞는지

팔에 맞는 커프로 바르게 측정합니다. 가정혈압이나 활동혈압검사로 병원에서만 높아지는지 살핍니다.

실제로 먹은 약

약 이름·용량·빠뜨린 날을 알려 주세요. 한 알 복합제로 복약을 정리하는 방법도 의사가 검토합니다.

생활과 다른 약

소염진통제·감기약·감초가 든 약, 염분 섭취를 점검합니다. 코골이와 수면무호흡도 함께 살핍니다.

전문 검사와 약 조정

안지오텐신계 약·칼슘통로차단제·이뇨제 세 약을 써도 높으면 전문 진료를 받습니다. 칼륨·콩팥 기능과 알도스테론 등 이차성 원인을 평가합니다.

연자 Q&A · 추가 약은 검사 결과에 맞춰 의사가 정합니다.

아산 28회 연수강좌 — 2026 고혈압 치료 update: 진료실에서 바로 적용하는 최신 전략(김대희)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

추가 약을 고르기 전에 검사와 조정이 이어집니다

연자 Q&A · 조절이 어려운 고혈압에서는 전문의가 순서대로 검토합니다

1

이뇨제부터 점검

현재 이뇨제의 종류와 용량이 알맞은지 보고, 콩팥 기능에 맞춰 조정합니다. 약을 스스로 더하지 마세요.

2

추가 약의 안전성

스피로놀락톤 또는 아밀로라이드 등을 검토할 때 칼륨과 콩팥 기능을 확인합니다.

3

계속 높다면 전문 평가

추가 강압에는 ARNI 계열로 바꾸는 방법도 검토합니다. 이차성 원인 검사와 약 조정을 함께 진행합니다.

현재 약 점검 → 피검사·원인 평가 → 전문의와 조정

호흡곤란이나 부종이 있으면 심부전 동반 여부도 평가합니다.

아산 28회 연수강좌 — 2026 고혈압 치료 update: 진료실에서 바로 적용하는 최신 전략(김대희)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

혈압약은 서로 다른 길로 작용합니다

혈관을 넓히거나, 소금 배출을 늘리거나, 심장의 일을 줄입니다.

혈압 호르몬을 막는 약

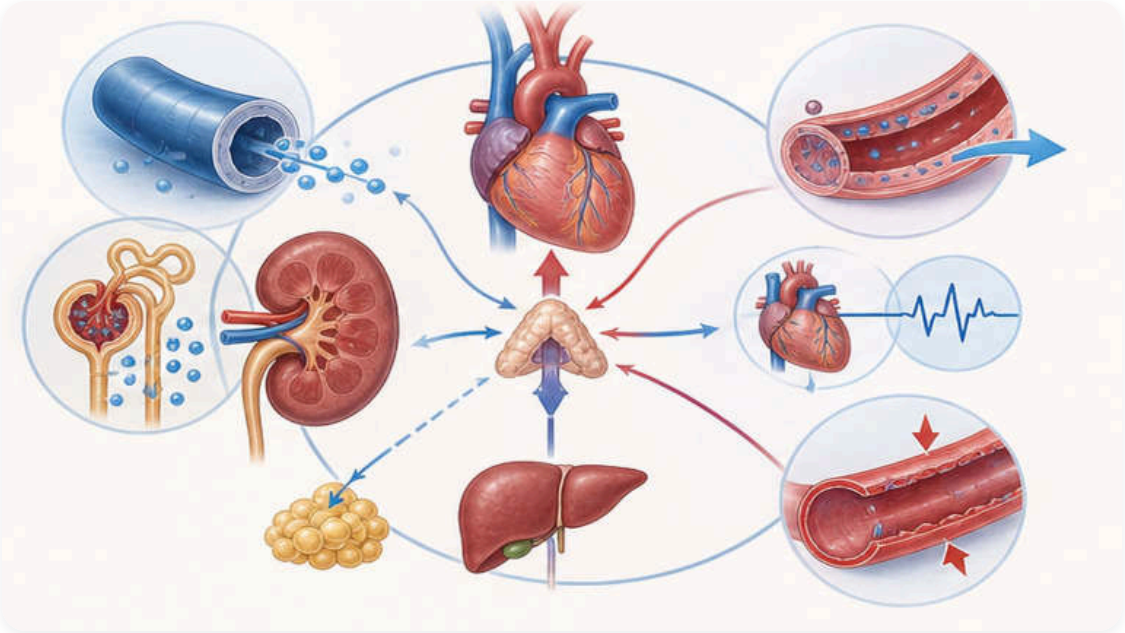
혈압을 올리는 호르몬의 작용을 막습니다. 한 종류는 마른기침이 생길 수 있고, 다른 종류는 기침이 드뭅니다.

칼슘차단제는 두 방식

한 종류는 혈관을 넓히고, 다른 종류는 맥박도 늦춥니다. 맥박을 늦추는 다른 약을 먹는다면 함께 알려 주세요.

나트륨 배설 · 교감 차단

티아지드 계열은 소금 배출을 늘리고, 알도스테론 차단 이뇨제(스피로노락톤 등)는 알도스테론이라는 호르몬을 막습니다. 베타차단제는 맥박과 심장의 일을 줄입니다.



기전이 다른 두 약을 더하면 서로의 보상 반응을 막아 효과가 커집니다

실천 · 이름이 비슷한 혈압약을 임의로 함께 드시지 마세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

같은 종류라도 복용법이 다릅니다

같은 종류(ARB) 약은 효과가 대체로 비슷하고, 직접 비교에서 조금 더 강한 것은 아질사르탄 하나입니다.

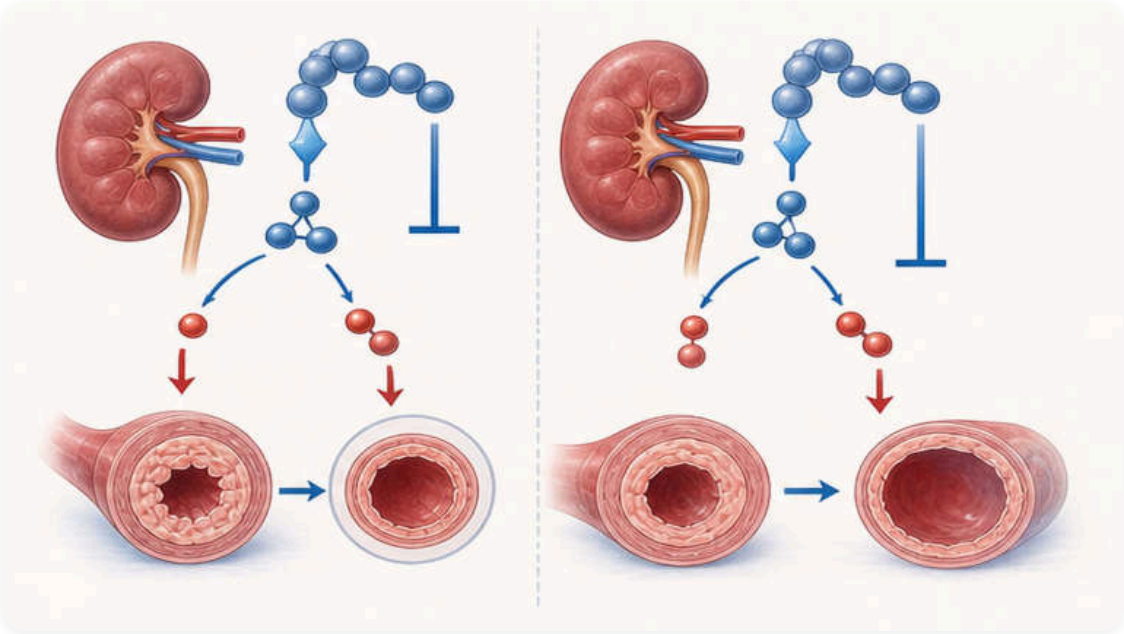
약 종류	어떻게 다른가요?	무엇을 살펴볼까요?
호르몬 억제약 (ARB)	대체로 비슷함 · 직접 비교에서 아질사르탄만 조금 더 강함	집에서 잰 혈압과 복용 시간을 알려 주세요.
호르몬 억제약 (ACE 억제제)	혈압을 낮추는 효과는 비슷하지만 마른기침이 더 흔할 수 있습니다.	기침이 계속되면 의사에게 알려 주세요.
혈관을 넓히는 약	종류에 따라 발목 붓기가 달라질 수 있습니다.	붓기가 심하면 의사가 약을 바꿀 수 있습니다.
맥박도 늦추는 약	혈관을 넓히면서 심장 박동도 늦춥니다.	맥박이 느려지거나 어지러우면 알려 주세요.
소변을 늘리는 약	약마다 작용이 이어지는 시간이 다릅니다.	피검사로 칼륨을 확인할 수 있습니다.
심장의 일을 줄이는 약	약마다 혈관을 넓히는 정도도 다릅니다.	피로와 맥박 변화를 기록해 주세요.

실천 · 같은 계열 안에서도 복용 시간·부작용이 달라 처방대로 드세요.

출처 · 마지막 장

기침이 생기는 약이 있습니다

마른기침·입술 붓기 등 몸의 변화를 살피세요.



시작 뒤 칼륨·크레아티닌을 확인합니다

실천 · 기침이 계속되면 진료받고, 얼굴·입술·혀가 붓거나 숨쉬기 어려우면 바로 응급실로 가세요.

기침이 생길 수 있는 종류

마른기침은 약 10%, 얼굴·입술이 붓는 응급 부작용은 0.1~0.7%로 보고됐습니다. 기침은 한국인에게 더 흔할 수 있습니다.

기침이 드문 종류

앞의 약과 혈압을 낮추는 효과는 비슷하고 마른기침은 드뭅니다. 앞의 약으로 얼굴이 부은 적이 있다면 꼭 알려 주세요.

두 약의 공통 주의

칼륨과 콩팥 기능을 확인해야 합니다. 임신 중이거나 양쪽 콩팥 동맥이 좁은 분에게는 쓰지 않으며, 두 계열을 함께 쓰지 않습니다.

출처 · 마지막 장

발목 붓기와 느린 맥박을 구분하세요

같은 칼슘차단제라도 혈관과 심장에 미치는 효과가 다릅니다.

혈관을 넓히는 칼슘차단제

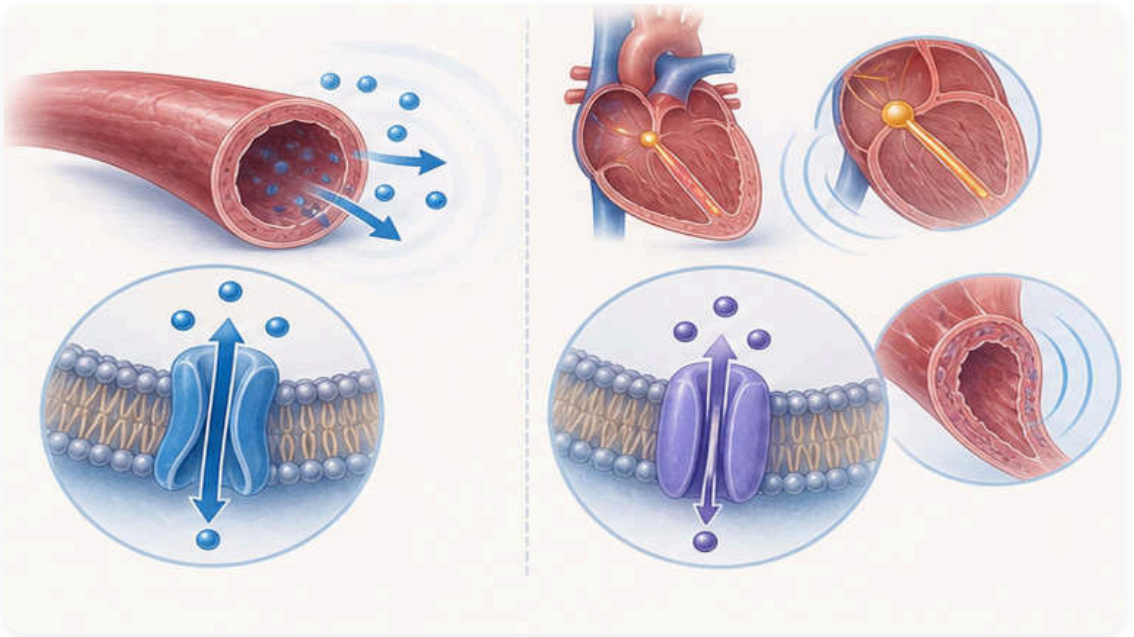
혈관을 넓혀 혈압을 낮춥니다. 발목이 붓거나 얼굴이 달아오르고, 두통이나 잇몸이 두꺼워지는 증상이 생길 수 있습니다. 증상을 기록해 의사에게 알려 주세요.

맥박도 늦추는 칼슘차단제

이 종류는 혈관을 넓히면서 맥박도 늦춥니다. 맥박이 너무 느려지거나 변비가 생기면 알려 주세요.

맥박을 늦추는 약의 주의점

심장 힘이 약하거나 심장 신호 전달에 문제가 있다면 의사에게 알려 주세요. 다른 맥박약과 함께 쓰면 맥박이 더 느려질 수 있습니다.



발목 붓기와 느린 맥박은 약을 바꿀 때 중요한 단서입니다

실천 · 발목 붓기나 맥박이 느려지는 증상을 진료 때 알려 주세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

소변을 늘리는 약의 차이

복용 뒤 피검사로 소금·칼륨·콩팥 기능을 확인할 수 있습니다.

약 종류	몸에 머무는 시간(반감기)	치료 중 확인할 것	환자가 기억할 점
클로르탈리돈	하루 12.5~25 mg · 몸에서 절반으로 줄어드는 데 40~60시간	다른 흔한 이뇨제보다 심장혈관 사건 차이는 없었고 칼륨이 더 낮아질 수 있었습니다.	안내받은 날에 피검사를 받으세요.
인다파미드	하루 1.5 mg 서방형 또는 2.5 mg · 14~18시간	혈당·지질 등에 미치는 영향이 비교적 적습니다.	복용 시간을 처방대로 지키세요.
히드로클로로티아지드	하루 25 mg · 6~12시간	작용 시간이 비교적 짧고 복합제에 흔히 들어 있습니다.	약 봉투에서 성분을 확인하세요.
스피로노락톤	세 약을 써도 혈압이 높을 때 의사가 하루 25~50 mg을 검토합니다.	시작 전에 콩팥 기능과 칼륨을 확인합니다.	칼륨 증가나 가슴 부위 변화가 생기면 알려 주세요.

실천 · 이뇨제를 시작했다면 안내받은 날짜에 피검사를 받으세요.

출처 · 마지막 장

새 증상이 생기면 알려 주세요

발목 붓기, 기침, 어지럼, 느린 맥박을 적어 오세요.

기침이 생길 수 있는 약

마른기침은 약 10%에서 보고됐고 한국인에게 더 흔할 수 있습니다. 얼굴·입술·혀가 부으면 바로 응급실로 가세요.

기침이 드문 호르몬 억제약

기침은 드물지만 칼륨과 콩팥 기능을 확인합니다. 앞의 약으로 얼굴이 부은 적이 있다면 이 약도 신중히 정해야 합니다.

혈관을 넓히는 약

발목 붓기·얼굴 달아오름·두통·잇몸 변화가 생길 수 있습니다. 부종이 심하면 의사가 다른 약으로 바꿀 수 있습니다.

맥박도 늦추는 약

맥박이 느려지거나 심장 신호 전달에 문제가 생기고 변비가 올 수 있습니다. 심장 힘이 약한 분은 악화될 수 있어 의사에게 알려 주세요.

이뇨제

칼륨·나트륨·마그네슘이 낮아짐 · 요산 상승·통풍 악화 · 혈당 상승 · 광과민성. 알도스테론 차단 이뇨제(스피로노락톤 등): 칼륨 증가·여성형 유방.

베타차단제

느린 맥박 · 피로 · 운동능력 저하 · 발기부전 · 사지냉감. **갑작스러운 중단 금지**(갑자기 끊으면 맥박이 빨라지거나 가슴 통증이 생길 수 있음).

실천 · 새 증상이 있어도 임의로 끊지 말고 처방 의사에게 연락하세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

함께 쓰면 위험한 조합

처방받는 곳이 여러 군데라면 모든 약을 알려 주세요.

⚠ 호르몬 억제약 두 종류를 함께 쓰지 않기

두 종류를 함께 쓰면 칼륨 상승과 갑작스러운 콩팥 손상이 늘었습니다. 당뇨병이나 콩팥병이 있으면 알리스키렌(또 다른 호르몬 억제약)도 함께 쓰지 않습니다.

맥박 조절형 칼슘차단제 + 베타차단제 신중

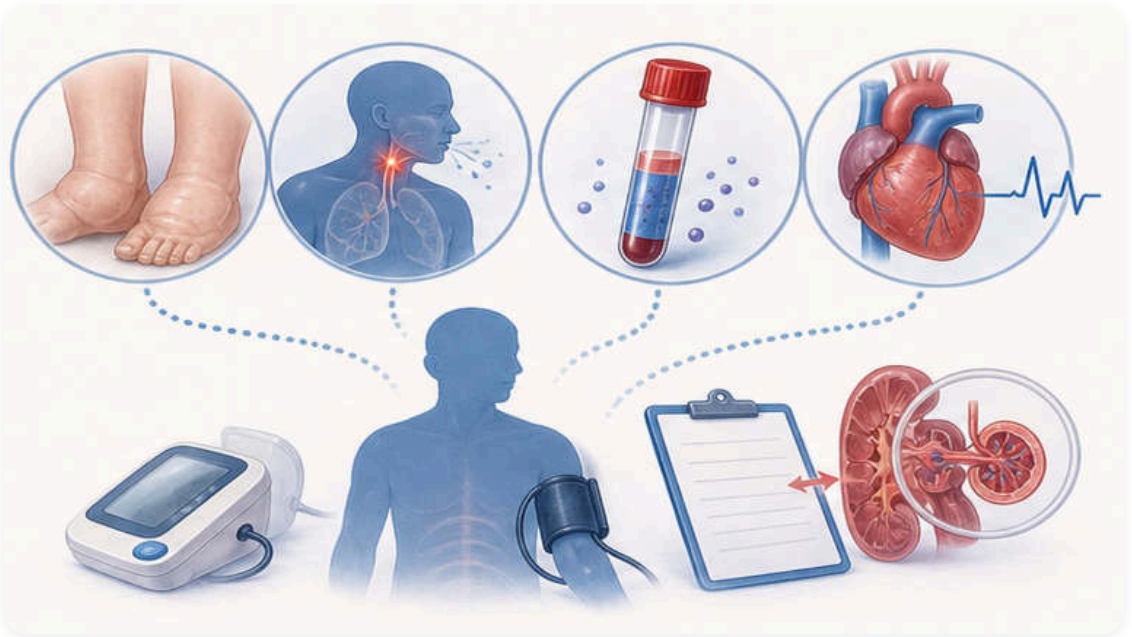
맥박이 심하게 느려지거나 심장 전기 신호 전달에 문제가 생길 수 있습니다.

임신 중 호르몬 억제약 금기

이 종류의 약은 태아의 콩팥에 해로울 수 있습니다. 임신 중이거나 계획 중이면 바로 의사에게 알려 주세요.

시작 뒤 확인

약 종류에 따라 피 속 칼륨·콩팥 기능·소금 성분·요산, 발목 붓기와 맥박을 확인합니다.



베타차단제는 서서히 줄여 끊습니다 — 갑자기 끊으면 맥박이 빨라지거나 가슴 통증이 생길 수 있습니다

실천 · 다른 병원 약과 임신 가능성을 처방 전에 꼭 알려 주세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

진료 전 이 목록을 확인하세요

가정 혈압 기록과 약 목록이 약 선택에 도움이 됩니다.

① 혈압 기록

집에서 잰 혈압을 가져오면 약을 더할지 정하는 데 도움이 됩니다.

② 약을 더할 때

의사는 작용이 다른 약을 함께 쓸 수 있습니다. 스스로 더하지 마세요.

③ 기침 기록

마른기침이 언제 시작됐고 얼마나 계속되는지 알려 주세요.

④ 소변을 늘리는 약

작용 시간이 긴 약도 있습니다. 피검사로 칼륨을 확인하세요.

⑤ 발목이 부으면

부종을 알려 주세요. 의사가 약을 바꿀 수 있습니다.

⑥ 심장병도 알리기

심부전·심장혈관병·빠른 맥박이 있다면 약 선택에 중요합니다.

⑦ 다른 병원 약

모든 처방전을 보여 주세요. 함께 쓰면 위험한 약이 있을 수 있습니다.

⑧ 혈압이 계속 높으면

의사가 칼륨과 콩팥 기능을 보고 약 추가를 검토합니다.

실천 · 진료 때 약 봉투와 가정 혈압 기록을 가져오세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

혈압약 상담 때 다시 보기

QR로 휴대폰에서 다시 볼 수 있습니다 · 함께 드리는 혈압약 세기 안내문도 읽어 보세요.

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

혈압약을 이해하기 위한 환자 설명자료입니다. 어떤 약을 얼마나 쓸지는 함께 앓는 병과 다른 약을 종합해 담당 의사가 정합니다.

참고한 자료

KSH 2022 · ESH 2023 · Law 2003(BMJ) · Wald 2009(Am J Med) · ONTARGET 2008 · VA NEPHRON-D 2013 · ALTITUDE 2012 · DCP(NEJM 2022) · PATHWAY-2(Lancet 2015) · White 2011 · Heran(Cochrane 2008) · CAFE · ALLHAT · SHEP · HYVET

SCAN TO REVISIT

진료실에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요